UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL PARAGUAY

5TO SEMESTRE

Dra Alicia González

Anatomía Patológica

Unidad I:

Tema: Acumulos Intracelulares



Acumulos Intracelulares

Dra. Alicia González

Acumulos Intracelulares

- Una de las manifestaciones metabólicas en las células es la **acumulación intracelular** de cantidades **anormales** de diversas sustancias

- Las sustancias acumuladas se dividen en 3 categorías**:**

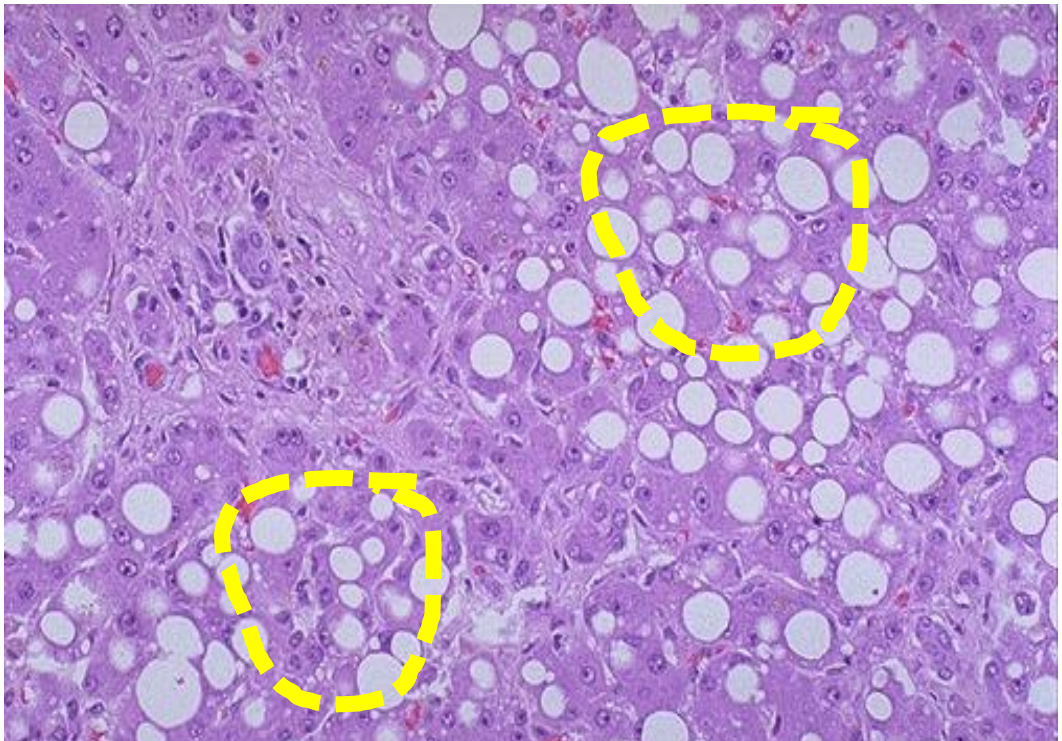
1- Un constituyente celular normal: acumulado en exceso como; agua, lípidos, proteínas, hidratos de carbono.

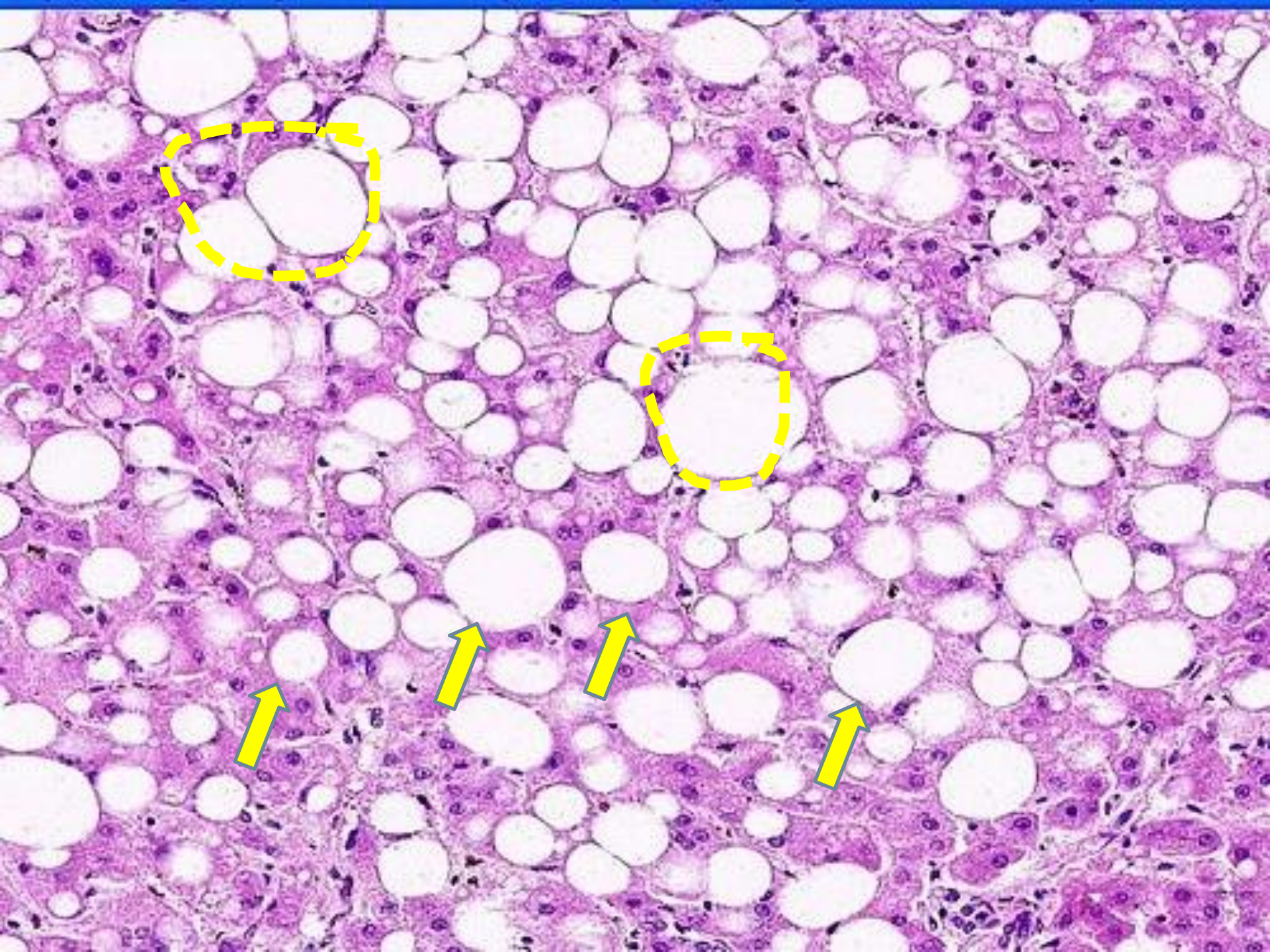
2- Una sustancia anormal que puede ser:

- **Endógena:** producto de síntesis o metabolismo anormal.
- **Exógena:** como minerales o productos de agentes infecciosos.
- **3- Un pigmento**

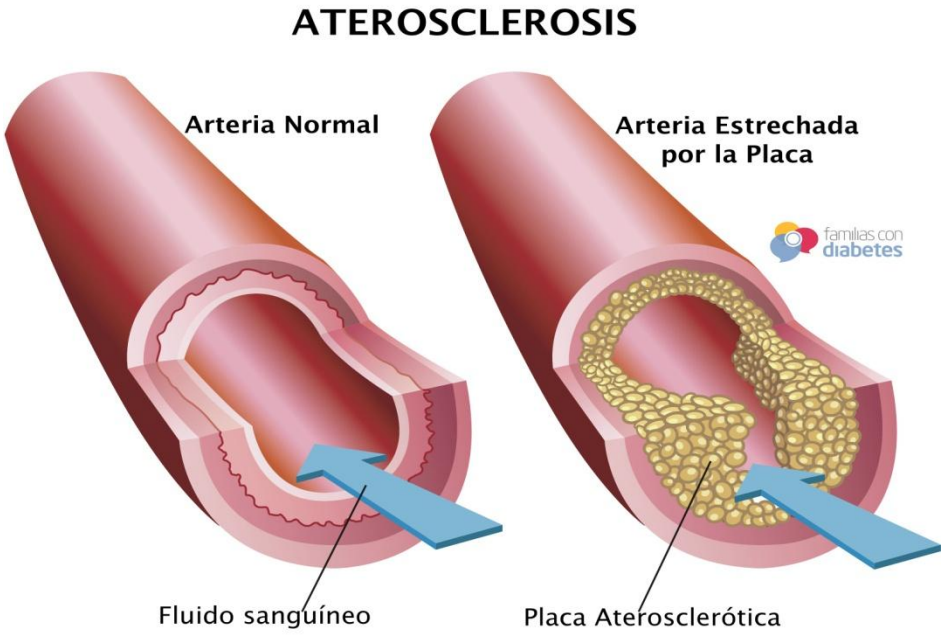
Lípidos: Una sustancia endógena normal que se produce a un ritmo normal o aumentado pero el metabolismo es inadecuado para eliminarla

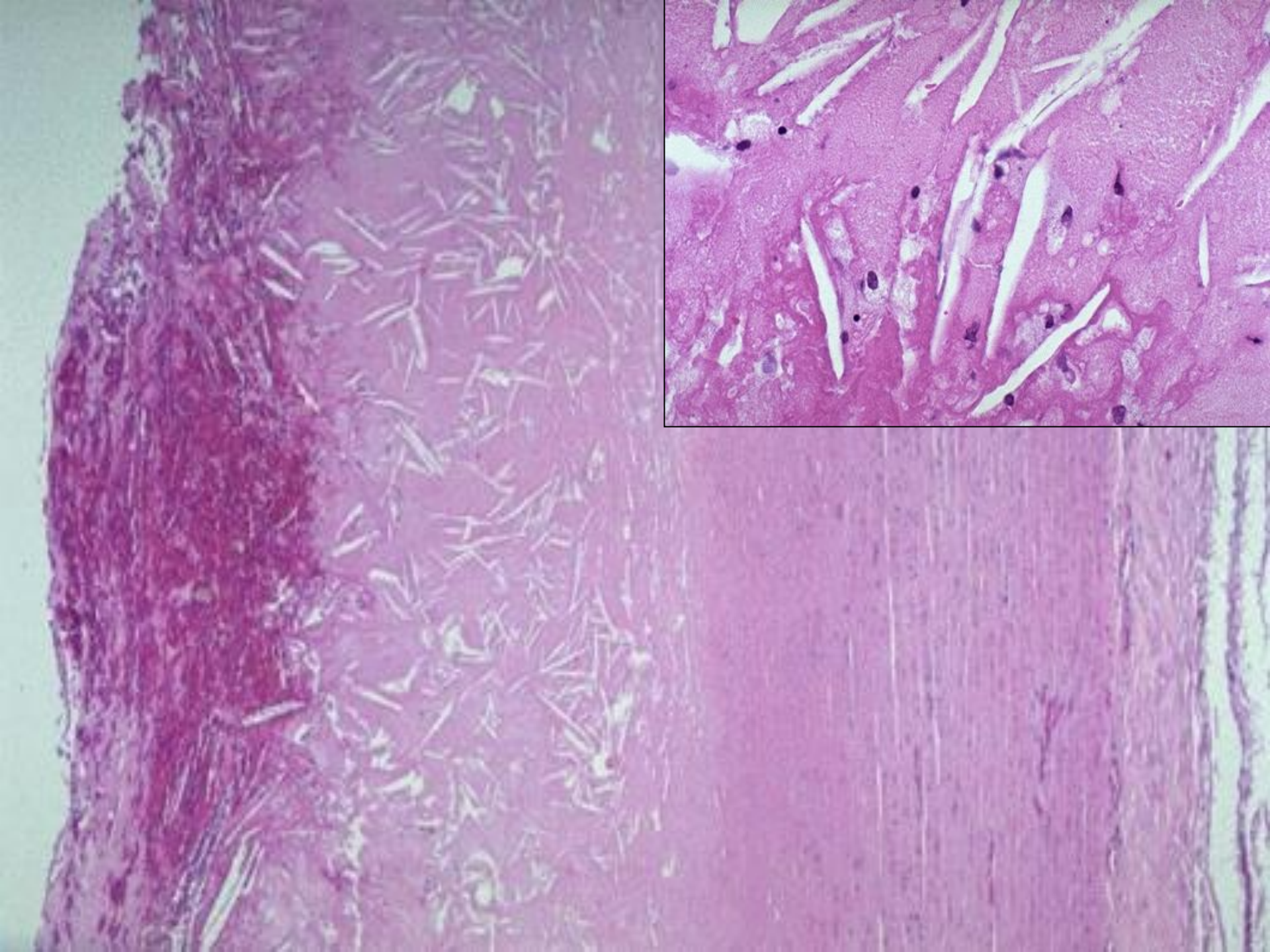
- Cambio graso en el hígado por acumulo de triglicéridos

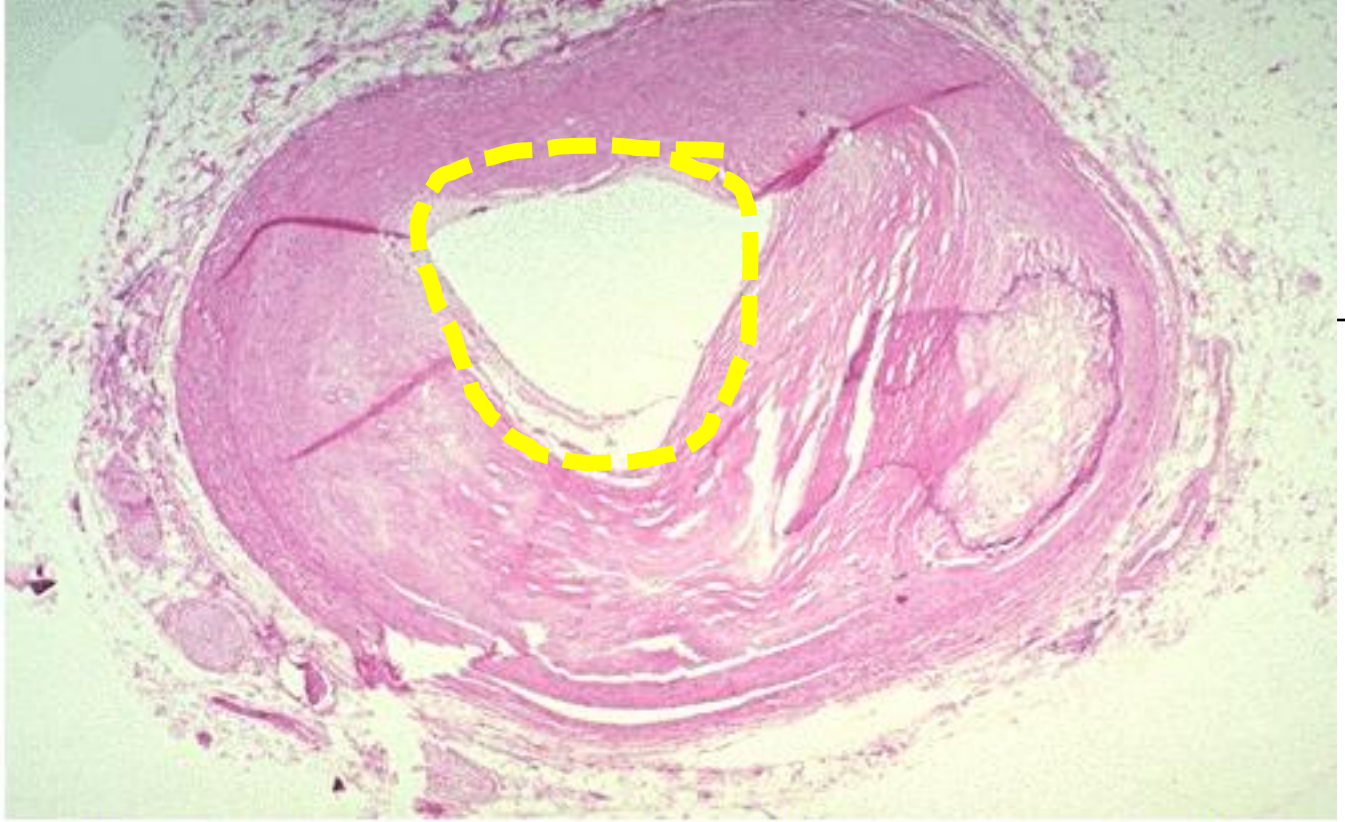




2-Aterosclerosis: en las placas ateroscleróticas las células **musculares lisas y macrófagos** dentro de la capa íntima de la aorta y de las grandes arterias estan llenas de vacuolas lípidicas la mayoría de las cuales están formadas por colesterol o esteres de colesterol. Tales células tienen apariencia espumosa y se ven en la capa íntima como ateromas amarillentos.

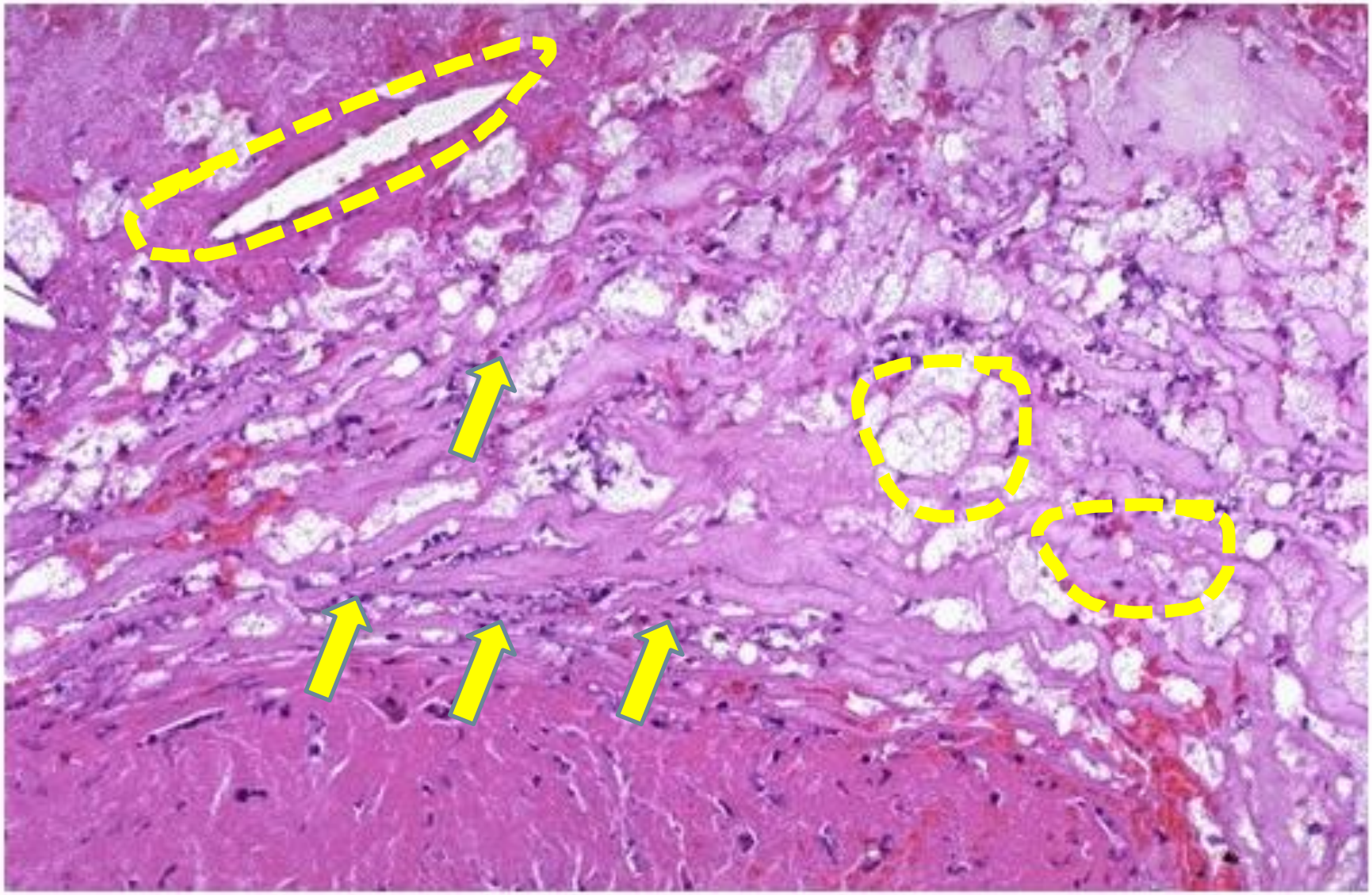






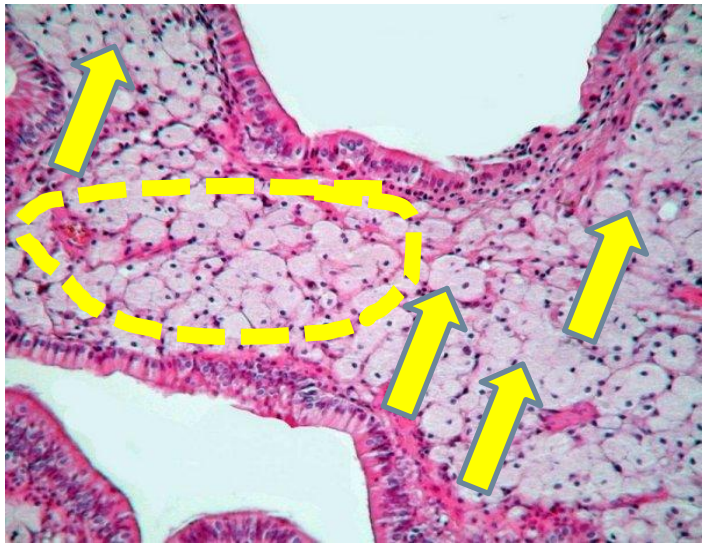
La arteria coronaria que se muestra aquí tiene un estrechamiento de su luz debido a la acumulación de placa aterosclerótica. El estrechamiento arterial coronario grave puede provocar angina, isquemia e infarto, dependiendo de la gravedad y la cronicidad de la oclusión. La placa que se muestra aquí es complicada por la **calcificación** .

La apoptosis de las células musculares lisas o la apoptosis de los macrófagos pueden conducir al desarrollo de pequeñas calcificaciones (microcalcificaciones) que pueden unirse en depósitos de calcio más grandes dentro de las placas de ateroma.



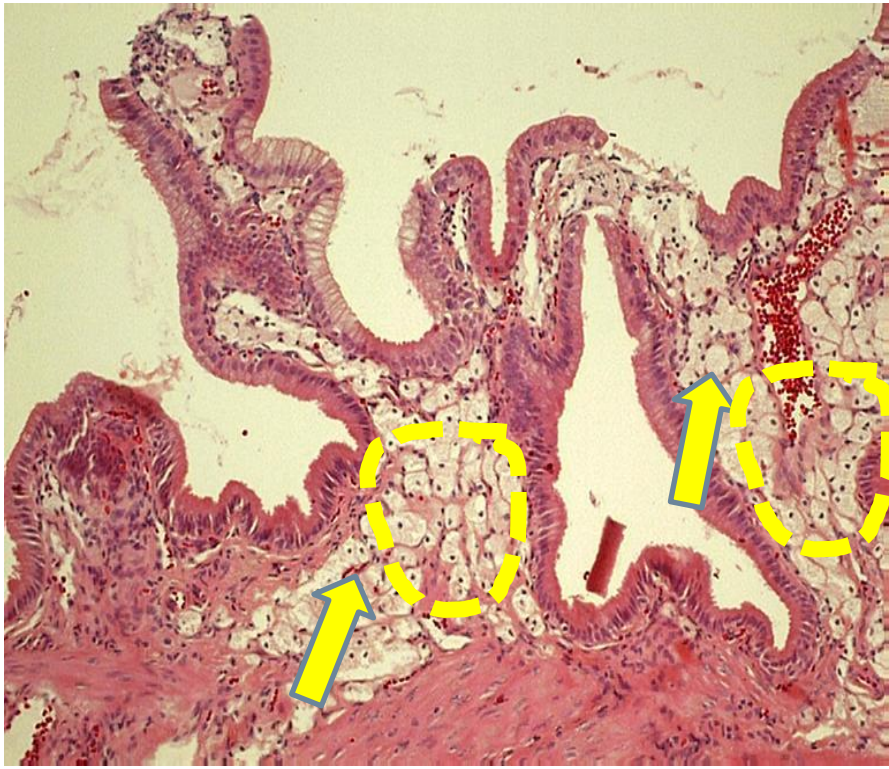
Este gran aumento del ateroma muestra numerosas **células de espuma** y una **hendidura de colesterol** ocasional . Unas pocas células inflamatorias de color azul oscuro (linfocitos) están dispersas dentro del ateroma.

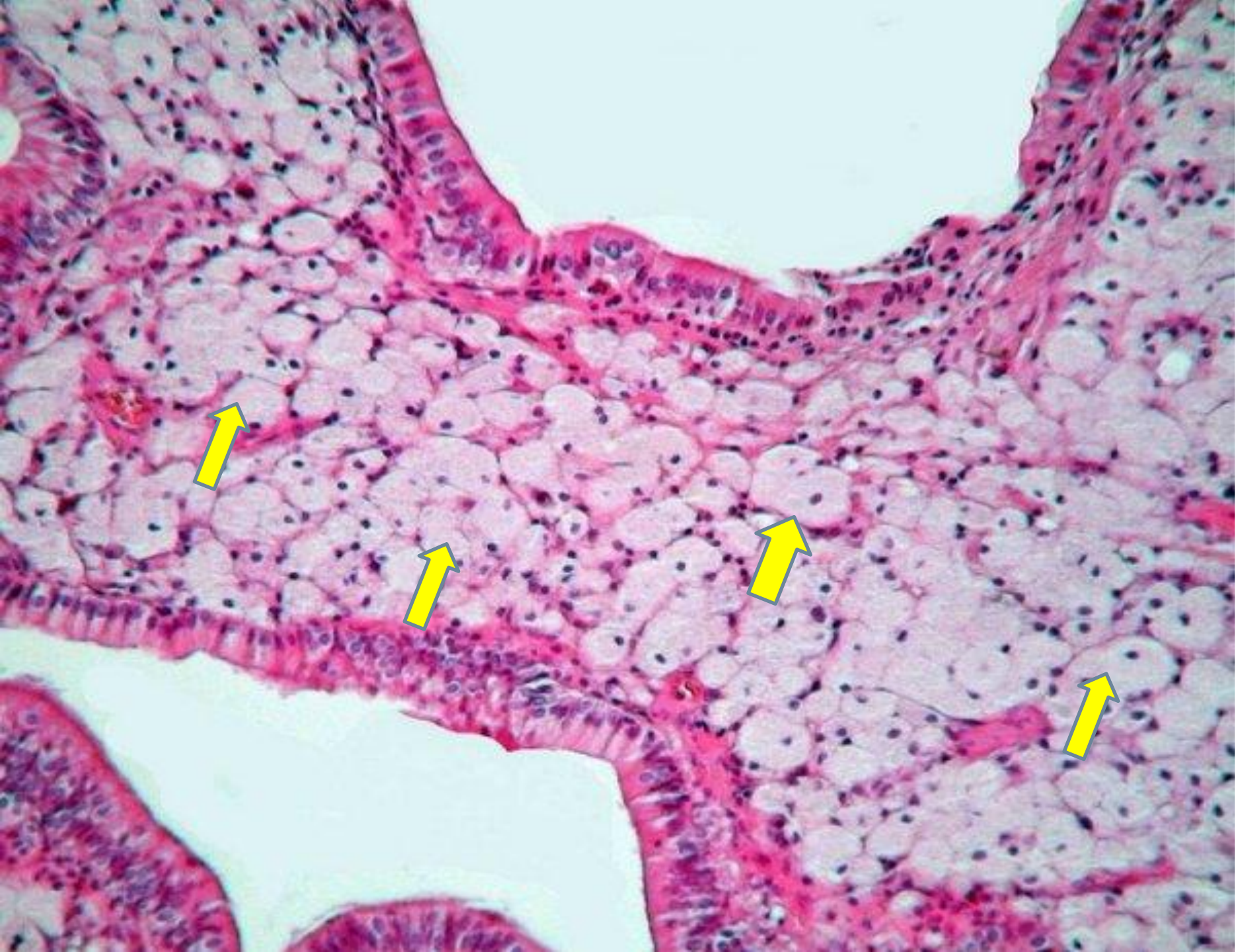
3-Inflamación y necrosis: los macrófagos espumosos se encuentran frecuentemente en **sitios de lesión celular e inflamación** debido a fagocitosis de colesterol de las membranas lesionadas, incluyendo células parenquimatosas, leucocitos, eritrocitos en los focos inflamatorios también se encuentran fosfolípidos y figuras de mielina cuando son abundantes proporcionan una **coloración amarillenta** en focos inflamatorios.

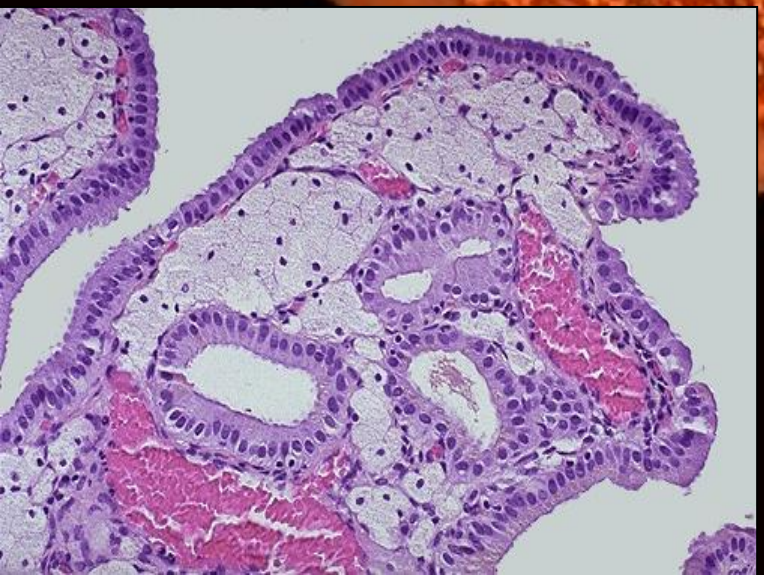


Colesterolosis: acumulo focal de macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia de la vesícula biliar.









Órgano: Vaso sanguíneo

Proceso: Acúmulos Intracelulares

Alteraciones: Se identifican hendiduras de colesterol, macrófagos espumosos cargados de lípidos y áreas de calcificación distrófica

Dx: Aterosclerosis

Órgano: Vesícula Biliar

Proceso : Acúmulos Intracelulares

Alteraciones: Se observan macrófagos espumosos cargados de colesterol en la lámina propia.

Dx: Colesterolosis

Órgano: Hígado

Proceso : Acúmulos Intracelulares

Alteraciones:Parénquima hepático con histoarquitectura alterada por presencia de hepatócitos con vacuolas lipídicas (triglicéridos).

Dx: Esteatosis hepática

Órgano: Piel

Proceso : Acúmulos Intracelulares

Alteraciones: epidermis con acantosis y papilomatosis. En dermis superficial y profunda se identifican células atípicas y pigmentos de melanina

Dx: Melanoma

MELANOMA

Tumor maligno del melanocito, más frecuentemente de la piel, pero también puede originarse en el ojo, meninges, boca, esófago, región anogenital.

Es más frecuente en la raza blanca, en ambos sexos por igual, en la edad adulta, pudiendo haber casos familiares

La topografía más habitual es la **espalda (varón), glúteos** y **miembros inferiores (mujeres),** pero en la población mestiza son frecuentes en **planta de los pies, dedos de las manos y región subungueal**

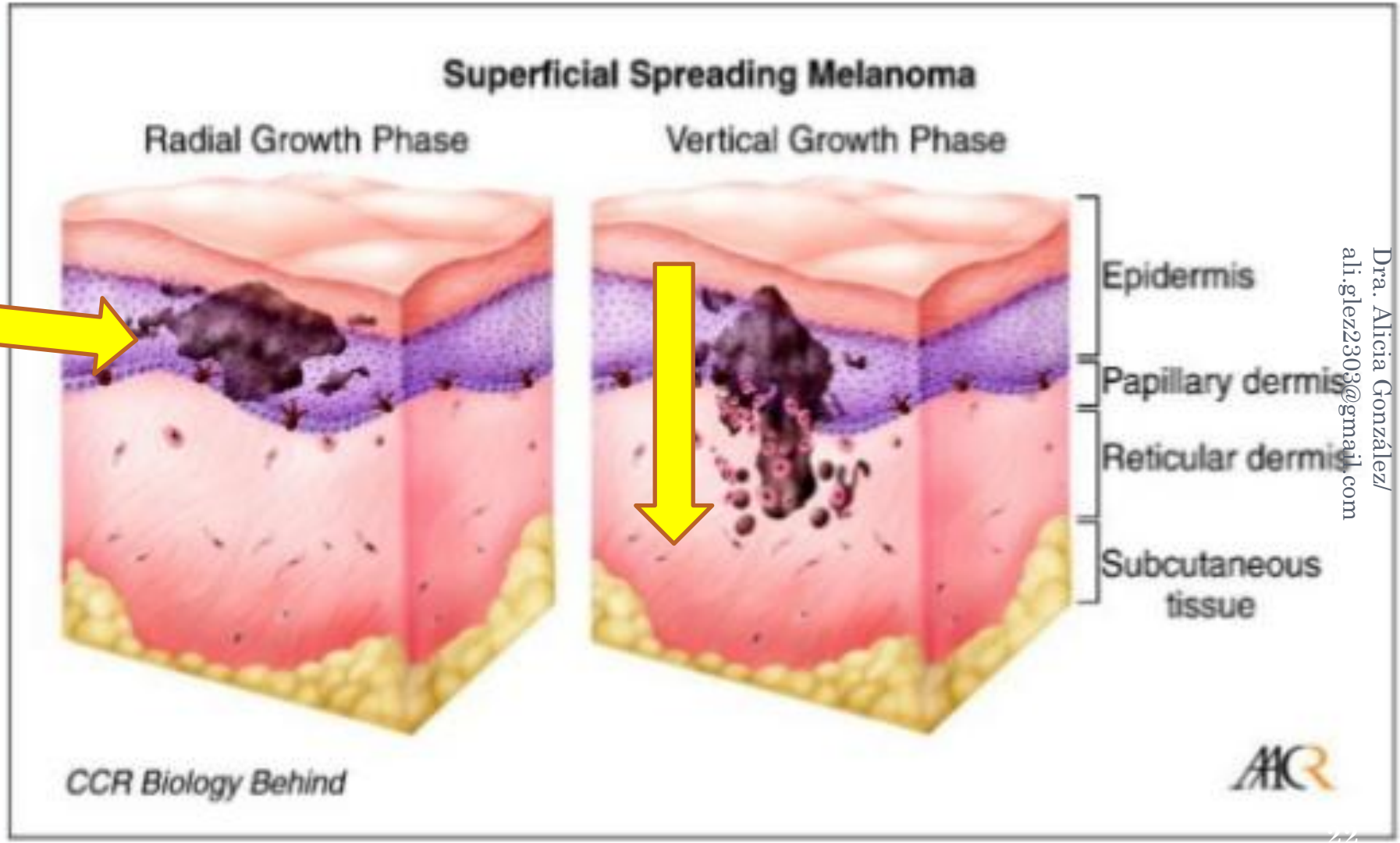
El **80% surge de novo o sobre piel sana,** el 20% restante lo hace sobre lesiones nevicas previas.

CLINICAMENTE

Comienzan como **manchas pigmentadas**, con **crecimiento horizontal (en superficie)** y **luego vertical(en profundidad),** apareciendo pápulas, nódulos, tumores que pueden ulcerarse.

Las lesiones son asimétricas, con pigmentación irregular, de varias tonalidades, **del marrón oscuro, rojo vivo** al **negro azulado**, pero existen formas sin color o amelanóticas

Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com

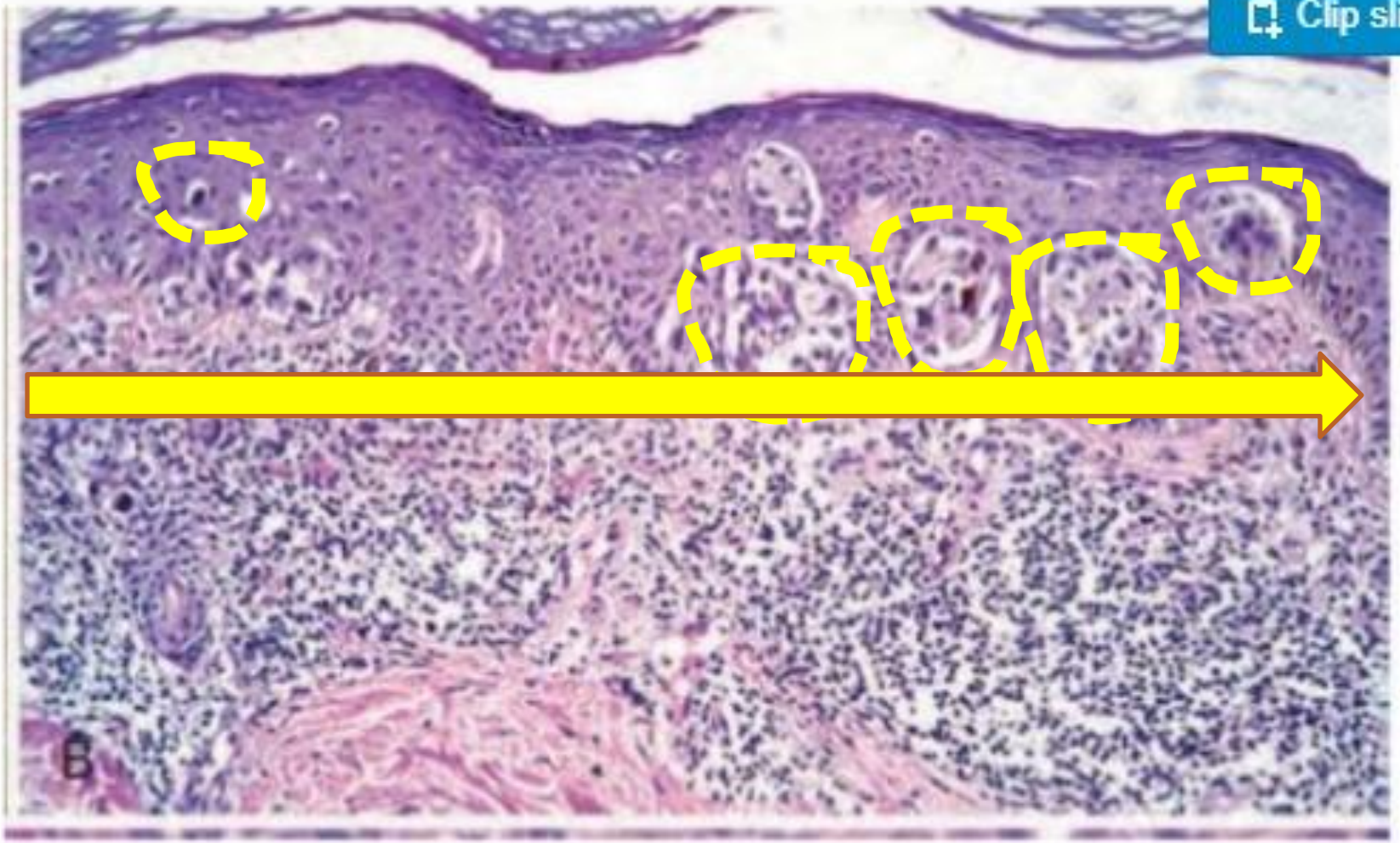


Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com

En resumen los signos de **AVISO** del melanoma son:

- 1- Aumento de tamaño del lunar pre existente
- 2- Prurito o dolor en el lunar pre existente
- 3- Desarrollo de una nueva lesión pigmentada durante la vida adulta
- 4- Irregularidad de bordes de una lesión pigmentada
- 5- Colores abirragados en el interior de la lesión pigmentada

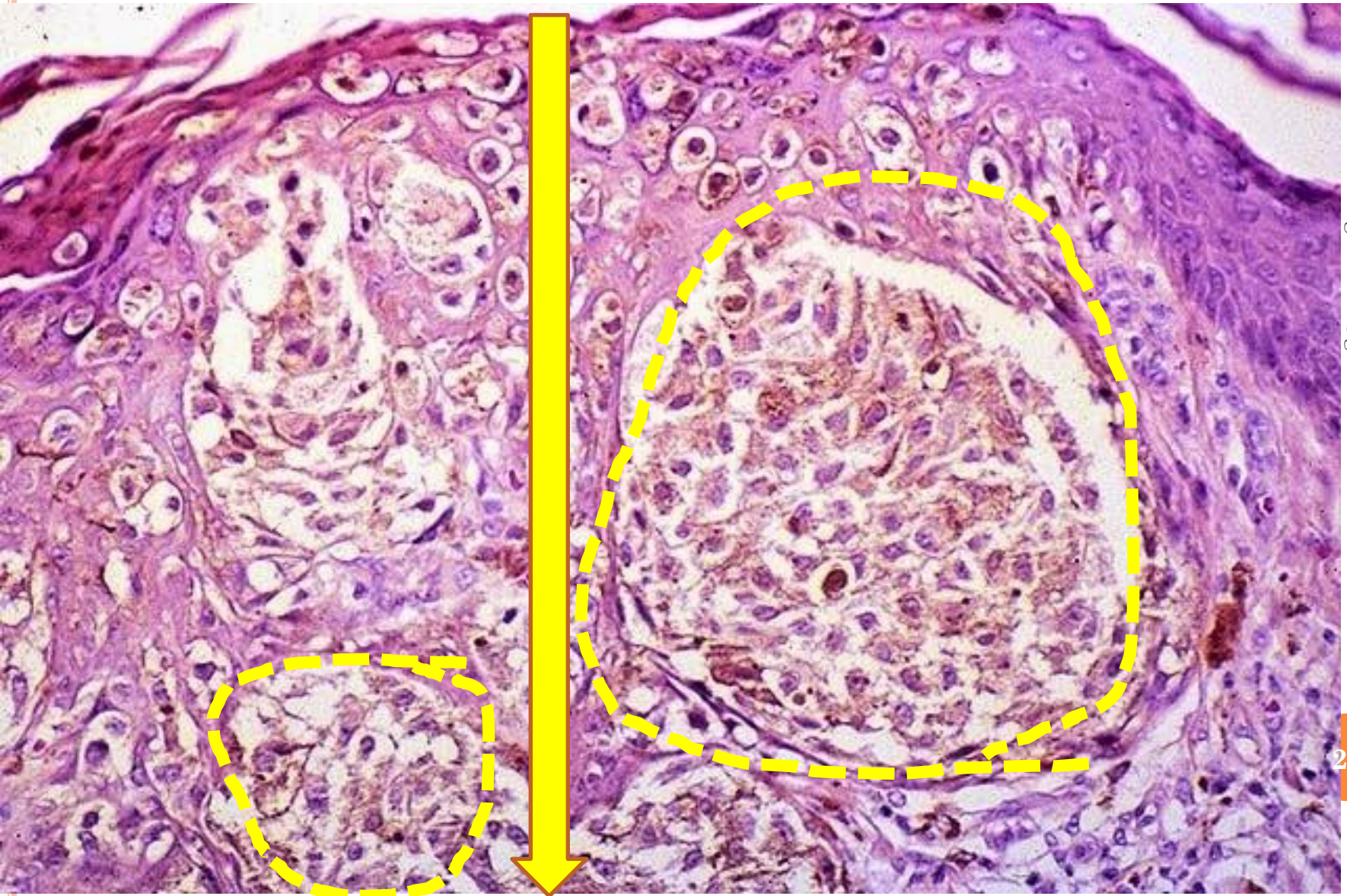
Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com



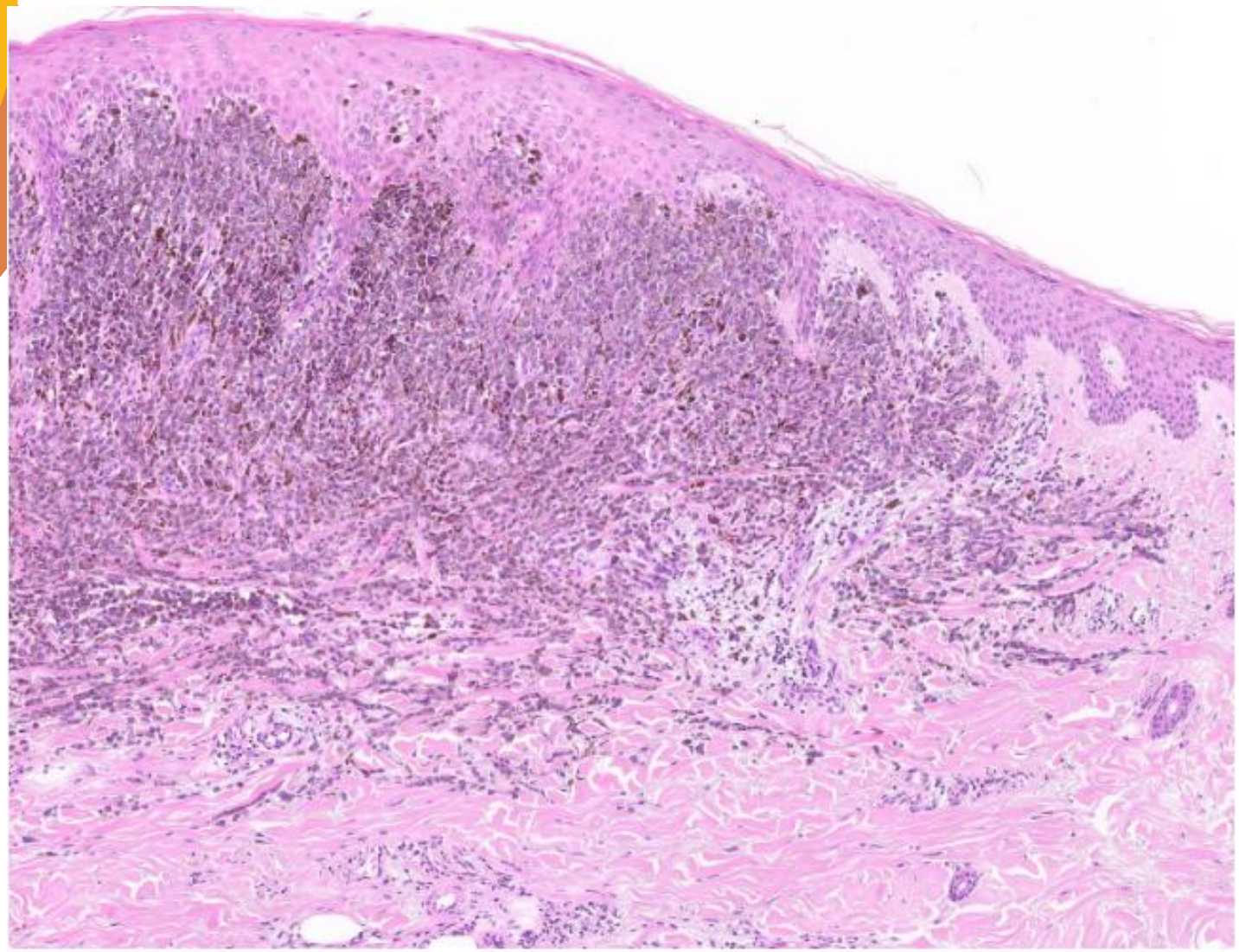
Fase de crecimiento radial con crecimiento en nidos o de células individuales dentro de la epidermis y una respuesta inflamatoria subyacente en la dermis.

Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com

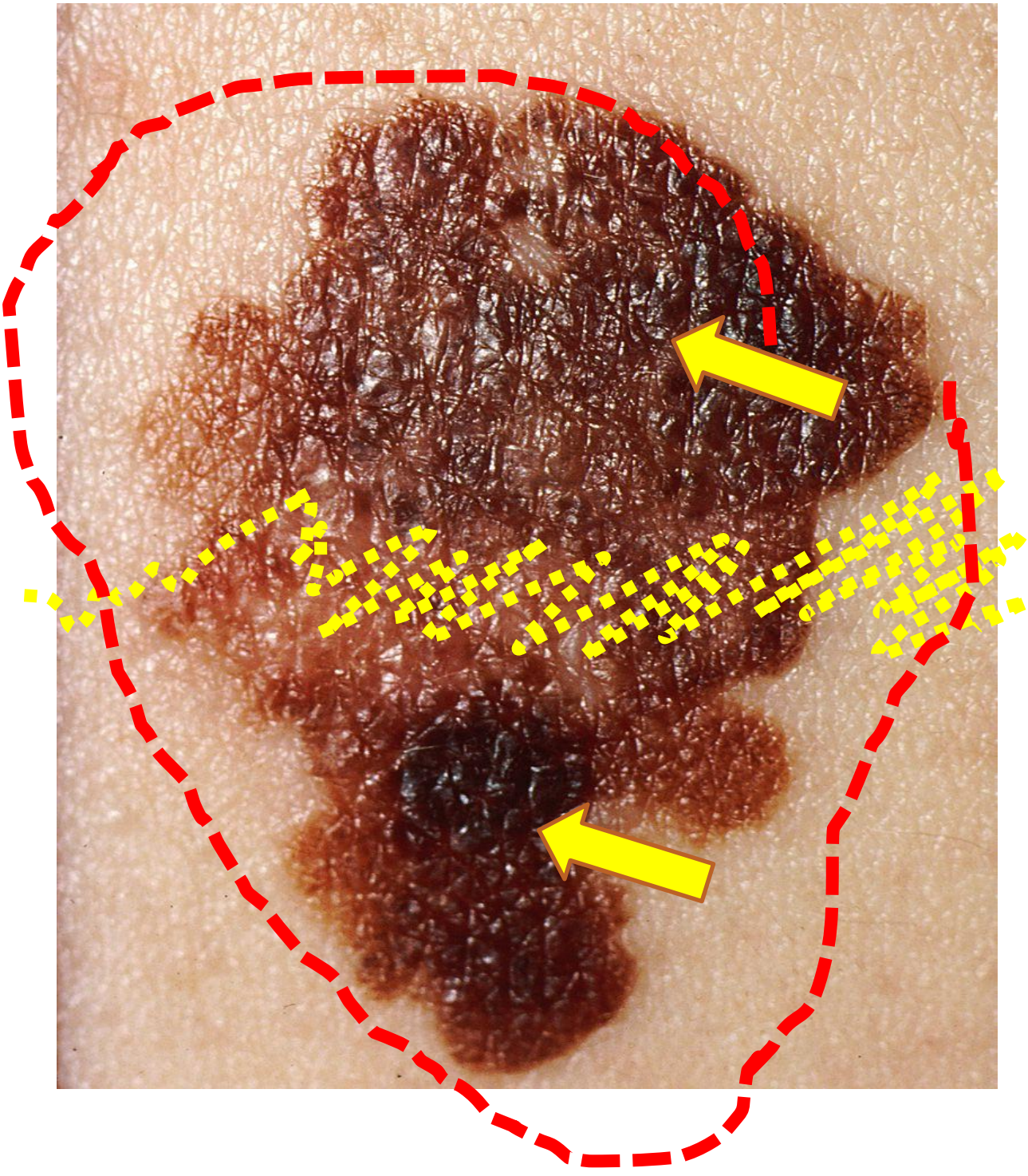
Crecimiento vertical



Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com



Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com



Gracias!!